Onkologická ambulance - neuroonkologie

Ambulantní vyšetření kontrolní

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111
Datum vyšetření: 6.10.2026

Diagnózy: C71.1 Zhoubný novotvar čelního laloku
I80.2 Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév dolních končetin

Závěr:
Glioblastom vlevo frontálně, IDH-wildtype, CNS WHO gr. 4, MGMT metylován, diag. 12/2025

- 2.12.2025 stp. subtotální resekci tumoru vlevo F
- 12.1.2026 - 20.2.2026 konkomitantní CHRT: RT 60 Gy/30 fr. + temozolomid 75 mg/m2, toleroval dobře
- 24.2.2026 DUS: hluboká žilní trombóza v. poplitea a vv. tibiales post. l. sin., od 24.2.2026 enoxaparin 80 mg s.c. á 12 hod.
- adjuvantní temozolomid: 1. cyklus 23.3.2026 150 mg/m2 (300 mg D1-5), 2. cyklus 20.4.2026 200 mg/m2 (400 mg D1-5)
- 12.5.2026 trombocytopenie G2 (PLT 54) a neutropenie G2 před 3. cyklem, 3. cyklus odložen, enoxaparin ponechán v plné dávce s kontrolou KO
- od 3. cyklu (26.5.2026) redukce na 150 mg/m2 (300 mg D1-5), 4. cyklus 22.6.2026
- MR mozku 14.7.2026: zvětšení sycení v okolí resekční dutiny vlevo F, nárůst edému, dif. dg. pseudoprogrese vs. progrese (RANO), doporučena kontrola MR za 8-10 týdnů
- od 15.7.2026 pro cefaleu znovu dexamethason 4 mg denně
- 20.7.2026 5. cyklus, 17.8.2026 6. cyklus (300 mg D1-5), adjuvance ukončena
- 4.8.2026 steroidní hyperglykémie (glykémie 12,9 mmol/l), dle PL zahájen metformin 500 mg 1-0-1
- vzestup kreatininu od 8/2026, užíval ibuprofen pro cefaleu, ibuprofen vysazen
- MR mozku 29.9.2026 (popis z NIS): další progrese sytící se složky v okolí resekční dutiny vlevo F na 24 x 19 mm, nové sytící se ložisko v genu corporis callosi 11 mm, závěr progrese dle RANO
- 1.10.2026 odeslán požadavek na PET/CT s 18F-FET, t.č. výsledek nemáme

Subjektivně:
Cefalea mírnější na dexamethasonu, únava, krvácení z dásní při čištění zubů. Paroxysmy neguje. Chuť k jídlu dobrá, žízeň a polyurie.

Objektivně:
KPS 70 %, ECOG 2. Hmotnost 88 kg. Lehká pravostranná hemiparéza (PHK 4/5, PDK 4+/5), lehká expresivní fatická porucha. Drobné hematomy na předloktích. LDK bez otoku.

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111 - Ambulantní vyšetření kontrolní 6.10.2026, pokračování

Medikace:
Dexamethason 4 mg 1-0-0, Levetiracetam 500 mg 1-0-1, Enoxaparin 80 mg s.c. á 12 hod., Metformin 500 mg 1-0-1, Ramipril 5 mg 1-0-0, Atorvastatin 20 mg 0-0-1, Pantoprazol 20 mg 1-0-0

Laboratoř dnes (odběr 6.10.2026 07:30):
PLT 97 x 10^9/l, kreatinin 142 µmol/l, eGFR 0,79 ml/s, glykémie 11,2 mmol/l, K 5,34 mmol/l - viz výsledkový list.

Zhodnocení:
Progrese GBM dle RANO 9/2026 po ukončení adjuvantního temozolomidu (6 cyklů). Přetrvávající trombocytopenie G1 na plné antikoagulaci, zhoršující se renální funkce, steroidní hyperglykémie.

Doporučení:
Případ zadávám k projednání na neuroonkologickém semináři.

Otázka na MDT: Je u progrese GBM indikována reresekce, případně reiradiace, nebo systémová léčba 2. linie (lomustin)? Prosím též o doporučení k další antikoagulaci (enoxaparin v plné dávce) vzhledem k trombocytopenii a klesající eGFR.

Dexamethason ponechat 4 mg denně, kontrola glykémií u PL.
Doplnit výsledek PET/CT s 18F-FET.
Nefrologické konzilium doporučeno.
Kontrola zde po semináři, s odběrem KO, biochemie.

Poznámka: Pacient poučen o povaze onemocnění a léčbě, rozumí a souhlasí.

MUDr. Hana Modřínová, onkologická ambulance

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111
Žádající: onkologická ambulance, MUDr. Hana Modřínová
Odběr: 6.10.2026 07:30, příjem vzorku: 6.10.2026 07:52, vydáno: 6.10.2026 09:48
Č. žádanky: S01-261006-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: 8,61 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: 6,77 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: **0,64** 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: **113** g/l [135 ... 175]
B_PLT: **97** 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - sacharidy:
S_GLC: **11,2** mmol/l [3.9 ... 5.6]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: **10,4** mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: **142** µmol/l [59 ... 104]
Renální funkce:
PT(KIDN)_EGFRCKDE: **0,79** ml/s/1,73 m2 [1.5 ... 99]
Sérum, plazma - enzymy:
S_ALT: 0,49 µkat/l [0.17 ... 0.84]
S_AST: 0,38 µkat/l [0.17 ... 0.84]
Krev - minerály:
S_NA: **135** mmol/l [136 ... 145]
S_K: **5,34** mmol/l [3.5 ... 5.1]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnil: Mgr. Tomáš Javorník, klinický biochemik

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111
Žádající: onkologická ambulance, MUDr. Hana Modřínová
Odběr: 4.8.2026 07:45, příjem vzorku: 4.8.2026 08:10, vydáno: 4.8.2026 10:31
Č. žádanky: S01-260804-02
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: 7,95 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: 6,04 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: **0,71** 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: **122** g/l [135 ... 175]
B_PLT: **131** 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - sacharidy:
S_GLC: **12,9** mmol/l [3.9 ... 5.6]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: **9,1** mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: **117** µmol/l [59 ... 104]
Renální funkce:
PT(KIDN)_EGFRCKDE: **0,99** ml/s/1,73 m2 [1.5 ... 99]
Sérum, plazma - enzymy:
S_ALT: 0,58 µkat/l [0.17 ... 0.84]
S_AST: 0,40 µkat/l [0.17 ... 0.84]
Krev - minerály:
S_NA: 136 mmol/l [136 ... 145]
S_K: 4,92 mmol/l [3.5 ... 5.1]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnil: Mgr. Tomáš Javorník, klinický biochemik

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111
Žádající: onkologická ambulance, MUDr. Hana Modřínová
Odběr: 12.5.2026 07:35, příjem vzorku: 12.5.2026 07:58, vydáno: 12.5.2026 09:20
Č. žádanky: S01-260512-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: **2,86** 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: **1,38** 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: **0,52** 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: **118** g/l [135 ... 175]
B_PLT: **54** 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - sacharidy:
S_GLC: 5,4 mmol/l [3.9 ... 5.6]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: 6,8 mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: 91 µmol/l [59 ... 104]
Renální funkce:
PT(KIDN)_EGFRCKDE: **1,32** ml/s/1,73 m2 [1.5 ... 99]
Sérum, plazma - enzymy:
S_ALT: **0,93** µkat/l [0.17 ... 0.84]
S_AST: 0,61 µkat/l [0.17 ... 0.84]
Krev - minerály:
S_NA: 141 mmol/l [136 ... 145]
S_K: 4,48 mmol/l [3.5 ... 5.1]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnil: Mgr. Tomáš Javorník, klinický biochemik

Onkologická ambulance - neuroonkologie

Ambulantní vyšetření vstupní

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111
Datum vyšetření: 8.1.2026

Diagnózy: C71.1 Zhoubný novotvar čelního laloku

Závěr:
Glioblastom vlevo frontálně, IDH-wildtype, CNS WHO gr. 4, diag. 12/2025

- 18.11.2025 první epileptický paroxysmus (fokální s generalizací), přivezen RZP na urg. příjem
- MR mozku 20.11.2025: expanze vlevo frontálně 42 x 38 mm s prstencovitým sycením a perifokálním edémem, přesun střední čáry o 4 mm
- 2.12.2025 stp. resekci tumoru vlevo F (neurochirurgie), subtotální resekce
- pooperační MR 4.12.2025: malé sytící se reziduum v zadním okraji resekční dutiny do 8 mm
- Histol. 9.12.2025: glioblastom, IDH-wildtype, CNS WHO grade 4, MGMT promotor metylován, Ki-67 cca 40 %

Anamnéza:
OA: arteriální hypertenze, hyperlipidémie, jinak vážněji nestonal. DM neguje.
FA: Dexamethason 4 mg 1-0-0, Levetiracetam 500 mg 1-0-1, Ramipril 5 mg 1-0-0, Atorvastatin 20 mg 0-0-1, Pantoprazol 20 mg 1-0-0
AA: neguje
Abusus: nekuřák, alkohol příležitostně
SA: ženatý, technik, t.č. PN

Objektivně:
KPS 80 %, ECOG 1. Výška 178 cm, hmotnost 84 kg, BSA 2,03 m2.
Lehká paréza PHK, řeč plynulá, bez fatické poruchy. Jizva po kraniotomii klidná.

Doporučení:
Indikována konkomitantní chemoradioterapie dle Stuppa: RT 60 Gy / 30 frakcí + temozolomid 75 mg/m2 denně (150 mg denně) po dobu RT, poté adjuvantní temozolomid 150-200 mg/m2 D1-5 á 28 dní, 6 cyklů.
Zahájení RT plánováno 12.1.2026.
Profylaxe PJP: Biseptol 480 mg 2-0-2 Po, St, Pá po dobu konkomitance.
Dexamethason postupně snižovat dle klinického stavu.
Odběr KO + biochemie dnes, poté KO á 7 dní během RT.

Poznámka: Pacient poučen o povaze onemocnění a léčbě, rozumí a souhlasí.

MUDr. Hana Modřínová, onkologická ambulance

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Křemínek Radovan, nar. 12.3.1964, poj. 111
Žádající: onkologická ambulance, MUDr. Hana Modřínová
Odběr: 8.1.2026 07:40, příjem vzorku: 8.1.2026 08:05, vydáno: 8.1.2026 10:12
Č. žádanky: S01-260108-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: **11,42** 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: **9,12** 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: 1,21 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: 141 g/l [135 ... 175]
B_PLT: 268 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - sacharidy:
S_GLC: **7,8** mmol/l [3.9 ... 5.6]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: 5,9 mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: 78 µmol/l [59 ... 104]
Renální funkce:
PT(KIDN)_EGFRCKDE: 1,58 ml/s/1,73 m2 [1.5 ... 99]
Sérum, plazma - enzymy:
S_ALT: 0,71 µkat/l [0.17 ... 0.84]
S_AST: 0,44 µkat/l [0.17 ... 0.84]
Krev - minerály:
S_NA: 139 mmol/l [136 ... 145]
S_K: 4,21 mmol/l [3.5 ... 5.1]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnil: Mgr. Tomáš Javorník, klinický biochemik